Catálogo de User Stories

Sistema integral de gestión para sala médica privada

Usuarios y acceso

US-01 — Registro y gestión de la cuenta de usuario

Must | 4 pts | 13,2 h | Sprint 1

Como visitante, quiero registrarme en la plataforma con mis datos personales, de contacto y mi obra social, y poder mantenerlos actualizados después, para acceder al sistema y para que la sala me contacte con información vigente.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El formulario solicita nombre, apellido, tipo y número de documento, fecha de nacimiento, teléfono, email, contraseña y obra social (entidad, plan y número de afiliado).
- La obra social puede declararse como «sin cobertura / particular»; el dato es declarativo y no se valida contra el padrón de la entidad.
- El sistema rechaza el registro si el documento o el email ya están asociados a otra cuenta.
- Al completarse el registro, la cuenta queda con rol Usuario y puede iniciar sesión inmediatamente. Ningún autorregistro otorga otro rol.
- Una vez registrado, el usuario puede consultar y modificar teléfono, email, domicilio y obra social desde «Mis datos».
- El número de documento y la fecha de nacimiento no son editables por el usuario; requieren intervención administrativa.
- Al cambiar el email, las notificaciones posteriores se envían a la nueva dirección, y el sistema confirma el guardado con un mensaje explícito.
- El manejo de contraseñas se resuelve con un servicio de terceros.

Depende de: ninguna. Es el punto de partida del árbol de dependencias.

Trazabilidad: RF-USR-01, RF-USR-07, RNF-01, RN-06, RN-11

US-02 — Inicio de sesión con interfaz según rol

Must | 3 pts | 9,9 h | Sprint 1

Como usuario registrado, quiero iniciar sesión con mis credenciales y llegar a la pantalla propia de mi rol, para acceder directamente a las funciones que me corresponden sin navegar por opciones ajenas.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El sistema valida las credenciales y redirige según el rol: usuario, médico, enfermera, administrativo o administrador.
- Enfermera y administrativo son roles separados y llegan a pantallas distintas; ninguno ve el menú del otro.
- Ante credenciales inválidas muestra un mensaje genérico que no revela si el usuario existe.
- El usuario puede cerrar sesión desde cualquier pantalla.
- Cada rol ve un menú distinto sobre una misma identidad visual.

Depende de: US-01 (cuenta de usuario) CC+2D

Trazabilidad: RF-USR-02, RNF-06, RN-04

US-03 — Alta y baja de usuarios internos

Must | 3 pts | 9,9 h | Sprint 1

Como administrador, quiero dar de alta, modificar y desactivar las cuentas de médicos, enfermeras y administrativos asignándoles su rol, para controlar quién accede al sistema sin depender del área técnica.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El administrador puede crear un usuario indicando datos personales y el rol que le asigna; es la única vía para crear una cuenta con un rol distinto de Usuario.
- Al asignar el rol Médico se indica la especialidad. El rol Médico es genérico: las especialidades son datos administrables, no roles distintos, de modo que incorporar una nueva no exige tocar el modelo de autorización.
- Las especialidades iniciales son clínica, pediatría y traumatología.
- Los roles Enfermera y Administrativo se asignan por separado y no son intercambiables.
- Posteriormente al registro, el sistema envía un correo al nuevo usuario para que defina su contraseña.
- Un usuario desactivado no puede iniciar sesión pero conserva su historial de actividad.
- No se permite eliminar físicamente usuarios que tengan turnos o registros asociados.

Depende de: US-02 (sesión y ruteo por rol) CC+2D

Trazabilidad: RF-USR-03, RF-USR-07, RF-USR-08, RNF-14, RN-01, RN-04, RN-11

Agenda médica

US-06 — Carga de disponibilidad mensual y validación de jornadas

Must | 5 pts | 16,5 h | Sprint 1

Como médico, quiero cargar los días y las franjas horarias en que atenderé durante el próximo mes y que el sistema verifique que respeto la cantidad de jornadas exigida, para que mi agenda se abra a los pacientes sin quedar incompleta.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El médico selecciona un mes y agrega franjas indicando día, hora de inicio y hora de fin. La franja es el horario corrido que trabaja ese día.
- El sistema no permite cargar franjas sobre fechas ya pasadas.
- Al confirmar, el sistema recorre cada semana del mes y verifica que existan como mínimo 2 y como máximo 7 jornadas con franjas cargadas.
- Si alguna semana queda por debajo del mínimo o por encima del máximo, la confirmación se bloquea y el sistema indica qué semanas incumplen y en qué sentido.
- Los límites de 2 y 7 jornadas semanales son parámetros configurables por el administrador.
- Las semanas parcialmente incluidas en el mes se evalúan según el criterio acordado con el cliente.
- El médico puede modificar o eliminar una franja mientras la disponibilidad no esté confirmada.

Depende de: US-03 (usuarios internos con rol asignado) CC+2D

Trazabilidad: RF-AGE-01, RN-02, RN-09

US-08 — Generación automática de turnos de 30 minutos

Must | 4 pts | 13,2 h | Sprint 1

Como sistema, quiero dividir cada franja horaria confirmada en turnos de 30 minutos, para que los pacientes tengan horarios concretos para reservar.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Al confirmarse la disponibilidad, el sistema genera un turno por cada intervalo consecutivo de 30 minutos dentro de la franja.
- La duración es fija para todas las consultas y todas las especialidades: no es configurable.
- Un intervalo sobrante menor a 30 minutos no genera turno.
- Cada turno generado queda en estado disponible, asociado al médico, la fecha y la hora.
- La generación es idempotente: reconfirmar la misma disponibilidad no duplica turnos.

Depende de: US-06 (disponibilidad mensual persistida) FC

Trazabilidad: RF-AGE-03, RN-09

US-11 — Vista de agenda del profesional

Must | 4 pts | 13,2 h | Sprint 1

Como médico, quiero consultar mi agenda en vista diaria, semanal y mensual, para organizar mi trabajo y saber a quién voy a atender.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Las tres vistas muestran los turnos con su estado: disponible, reservado, cumplido, ausente o cancelado.
- En los turnos reservados se muestra el nombre del paciente y el motivo si fue indicado; si el turno fue reservado por otra persona, se identifica también a quién lo reservó.
- El médico puede navegar entre períodos sin recargar toda la pantalla.
- La vista diaria ordena los turnos cronológicamente e identifica los huecos libres.

Depende de: US-08 (turnos de 30 minutos generados) CC+2D

Trazabilidad: RF-AGE-05

Notificaciones

US-21 — Servicio de envío de notificaciones por email

Must | 3 pts | 9,9 h | Sprint 2

Como administrador, quiero contar con un servicio único de envío de correo con plantillas y reintentos, para que todas las notificaciones del sistema sean consistentes y auditables.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Existe un único componente responsable del envío, usado por todos los módulos.
- Las plantillas de cada tipo de notificación están parametrizadas y son editables sin tocar el código de negocio.
- Los envíos fallidos se reintentan una cantidad acotada de veces antes de marcarse como fallidos.

Depende de: US-01 (cuenta de usuario) CC+2D

Trazabilidad: RF-NOT-01

Vacunatorio

US-24 — Catálogo de vacunas

Must | 2 pts | 6,6 h | Sprint 2

Como enfermera, quiero administrar el listado de vacunas que aplica la sala, para trabajar sobre datos normalizados y no sobre texto libre.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Se pueden crear, modificar y desactivar vacunas indicando denominación, laboratorio y esquema de dosis.
- Una vacuna desactivada no puede asignarse a turnos nuevos.
- No se permiten dos vacunas activas con la misma denominación y laboratorio.
- El catálogo es la única fuente de datos para el resto del módulo y para la búsqueda de turnos de vacunación.
- El catálogo no administra existencias: se asume que toda vacuna activa tiene stock disponible.

Depende de: US-03 (usuarios internos con rol asignado)

Trazabilidad: RF-VAC-01, RN-05

US-63 — Agenda del vacunatorio

Must | 3 pts | 9,9 h | Sprint 3

Como enfermera, quiero cargar la disponibilidad del vacunatorio para que el sistema publique sus turnos, para que los pacientes puedan reservar la vacunación sin pasar por el mostrador.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- La enfermera carga días y franjas horarias de atención del vacunatorio del mismo modo en que el médico carga la suya.
- La agenda del vacunatorio es independiente de las agendas médicas: no comparte turnos, disponibilidad ni reglas de validación.
- La regla de 2 a 7 jornadas semanales no aplica al vacunatorio: la enfermera define libremente sus jornadas.
- Confirmada la disponibilidad, el sistema genera los turnos y los publica a los pacientes automáticamente.
- Las dos enfermeras ven y administran la misma agenda del vacunatorio.

Depende de: US-03 (usuarios internos con rol asignado), US-08 (turnos de 30 minutos generados)

Trazabilidad: RF-VAC-09, RF-AGE-04, RN-08

US-28 — Turno de vacunación

Must | 3 pts | 9,9 h | Sprint 3

Como usuario, quiero sacar un turno de vacunación eligiendo la vacuna, el horario y, opcionalmente, un rango de fechas, para vacunarme sin tener que llamar ni acercarme a la sala.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El usuario selecciona la vacuna del catálogo y un turno disponible de la agenda del vacunatorio.
- Puede filtrar los turnos disponibles por rango de fechas, igual que en la búsqueda de turnos médicos (US-10).
- No se verifica stock: se asume disponibilidad permanente de dosis, por lo que ninguna reserva se rechaza por ese motivo.
- La enfermera y el personal administrativo también pueden otorgar el turno desde el mostrador, en nombre del paciente.
- Puede reservarse a nombre de otra persona, igual que un turno médico, cargando sus datos y su obra social (US-64).
- El turno de vacunación puede superponerse con un turno médico de la misma persona; el sistema no lo impide ni lo advierte como error.
- El paciente recibe la confirmación del turno por email.

Depende de: US-13 (turno reservado), US-24 (catálogo de vacunas), US-63 (agenda del vacunatorio), US-64 (reserva a nombre de otra persona)

Trazabilidad: RF-VAC-05, RF-TUR-01, RF-TUR-11, RN-05, RN-08

US-29 — Registro de aplicación de dosis

Must | 1 pt | 3,3 h | Sprint 3

Como enfermera, quiero registrar cada dosis aplicada con todos sus datos, para dejar trazabilidad sanitaria de qué se aplicó y a quién.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El registro guarda paciente, vacuna, dosis del esquema, fecha, hora y enfermera responsable.
- La enfermera responsable se toma del usuario autenticado, no se ingresa manualmente.
- No se registra lote ni se descuenta stock, por la decisión de asumir disponibilidad permanente.
- El registro no puede eliminarse; una corrección se hace por anulación con motivo.
- La aplicación registrada queda vinculada al turno de vacunación si existió.

Depende de: US-28 (turno de vacunación)

Trazabilidad: RF-VAC-06, RNF-04, RN-05

US-57 — Carnet de vacunación del paciente

Should | 1 pt | 3,3 h | Sprint 3

Como paciente, quiero consultar las vacunas que me aplicaron en la sala, para conocer mi esquema sin tener que preguntarlo.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El listado muestra vacuna, fecha de aplicación y dosis del esquema.
- Se indica si el esquema quedó incompleto según las dosis definidas para esa vacuna.
- El listado puede descargarse en PDF.
- Solo incluye aplicaciones registradas en la sala.

Depende de: US-29 (aplicación de dosis registrada)

Trazabilidad: RF-VAC-08, RNF-03

Reserva de turnos

US-10 — Búsqueda de turnos por especialidad, profesional y rango de fechas

Must | 4 pts | 13,2 h | Sprint 2

Como paciente, quiero poder buscar turnos filtrando por especialidad, profesional y rango de fechas, para encontrar rápidamente un horario que me sirva sin llamar por teléfono.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Al confirmar la disponibilidad, los turnos generados quedan visibles para los pacientes sin intervención manual; antes de la confirmación, ningún turno de ese mes es visible.
- La agenda muestra únicamente los turnos futuros y disponibles.
- El usuario puede filtrar por especialidad, por profesional o por ambos.
- El rango de fechas por defecto son los próximos treinta días.
- Los resultados se agrupan por día y se ordenan cronológicamente, mostrando especialidad, profesional, fecha y hora de cada turno.
- Si no hay turnos que cumplan el filtro, se informa con un mensaje claro y se sugiere ampliar el rango.
- La búsqueda responde en menos de tres segundos en condiciones normales de uso.

Depende de: US-08 (turnos de 30 minutos generados) FC

Trazabilidad: RF-AGE-04, RF-TUR-01, RNF-07, RN-03, RN-08

US-13 — Reserva de turno con control de concurrencia

Must | 5 pts | 16,5 h | Sprint 2

Como usuario, quiero seleccionar un turno disponible y confirmarlo de forma atómica, para asegurarme la atención en el horario elegido sin riesgo de que otro paciente reserve el mismo turno al mismo tiempo.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El usuario ve un resumen con profesional, especialidad, fecha y hora antes de confirmar.
- Al confirmar, el turno pasa a estado reservado de forma atómica sobre el registro del turno y deja de aparecer en las búsquedas.
- Si dos pacientes intentan reservar el mismo turno ante solicitudes concurrentes, el segundo recibe un mensaje indicando que ya no está disponible y vuelve a los resultados de búsqueda actualizados.
- Existe una prueba que simula dos reservas concurrentes sobre el mismo turno y verifica que solo una prospere; en ningún caso el sistema queda con dos reservas activas para el mismo turno.
- El turno reservado queda visible en la sección de turnos del usuario, identificando a nombre de quién está.
- El usuario puede indicar opcionalmente un motivo de consulta.
- No se puede reservar un turno cuyo horario ya pasó.
- Una vez reservado, el turno no puede modificarse: la única operación disponible sobre él es la cancelación.

Depende de: US-10 (agenda publicada y búsqueda de disponibilidad) CC+2D

Trazabilidad: RF-TUR-02, RF-AGE-09, RF-TUR-09, RNF-05, RN-10

US-14 — Confirmación de reserva por email

Must | 2 pts | 6,6 h | Sprint 2

Como usuario, quiero recibir un email al confirmar el turno, para tener constancia de la reserva fuera del sistema.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El email se envía dentro del minuto posterior a la confirmación.
- Incluye profesional, especialidad, fecha, hora y dirección de la sala.
- Si el turno se reservó a nombre de otra persona, el email indica de quién es el turno.
- Incluye instrucciones para cancelar el turno.
- Si el envío falla, la reserva se mantiene válida y el fallo queda registrado para reintento.

Depende de: US-13 (turno reservado) FC, US-21 (servicio de envío de email) FC.

Trazabilidad: RF-TUR-03, RF-NOT-01

US-15 — Recordatorio automático de turno

Must | 2 pts | 6,6 h | Sprint 2

Como paciente, quiero recibir un recordatorio por email antes de mi turno, para no olvidarme de asistir.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El sistema envía el recordatorio con la antelación configurada por el administrador; el valor inicial son 24 horas.
- No se envía recordatorio de turnos cancelados.
- Se envía un único recordatorio por turno, sin duplicados ante reintentos del proceso.
- El proceso corre de forma automática y deja registro de cada envío.

Depende de: US-13 (turno reservado) FC, US-21 (servicio de envío de email) FC

Trazabilidad: RF-TUR-04, RF-NOT-01

US-16 — Cancelación de turno por el paciente

Must | 2 pts | 6,6 h | Sprint 2

Como usuario, quiero cancelar un turno que reservé, para liberar el horario si no se va a poder asistir.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El usuario puede cancelar desde su listado de turnos, con confirmación previa, tanto los propios como los reservados a nombre de otra persona.
- El turno cancelado vuelve al estado disponible y reaparece en las búsquedas.
- La cancelación se permite hasta la antelación mínima configurada; el valor inicial son 24 horas.
- La cancelación es la única modificación admitida sobre un turno reservado. Cambiar de horario implica cancelar y volver a reservar.
- El usuario y la sala reciben un email de aviso de la cancelación.
- El turno cancelado queda registrado en el historial, no se elimina.

Depende de: US-13 (turno reservado) FC, US-21 (servicio de envío de email) FC

Trazabilidad: RF-TUR-05, RF-AGE-09, RN-10

US-18 — Registro del estado del turno

Must | 2 pts | 6,6 h | Sprint 2

Como médico o administrativo, quiero marcar si el paciente asistió, no asistió o fue atendido, para que los reportes de asistencia reflejen lo que realmente ocurrió.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Los estados posibles son reservado, cumplido, ausente y cancelado.
- El estado solo puede modificarse el día del turno o posteriormente; el cambio de estado no constituye una modificación de la reserva en los términos de RF-AGE-09.
- Un turno cumplido habilita la carga de la ficha de diagnóstico y el registro del pago.
- El sistema deja constancia de quién cambió el estado y cuándo.

Depende de: US-13 (turno reservado) FC

Trazabilidad: RF-TUR-07

US-64 — Reserva de turno a nombre de otra persona

Must | 2 pts | 6,6 h | Sprint 2

Como usuario, quiero reservar turnos a nombre de otra persona cargando sus datos y su obra social, para gestionar los turnos de un familiar o de alguien a mi cargo sin que tenga que registrarse.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Al reservar, el usuario elige entre «para mí» y «para otra persona».
- Si reserva para otra persona, el formulario solicita nombre, apellido, documento, fecha de nacimiento y obra social (entidad, plan y número de afiliado) de esa persona.
- La opción está disponible para todos los profesionales y especialidades.
- Si la persona ya fue cargada antes, el usuario la selecciona de su listado sin reingresar los datos.
- El importe de la consulta se calcula con la cobertura de la persona atendida, no con la de quien reserva.
- Las confirmaciones, recordatorios y avisos de cancelación se envían al usuario que reservó.
- El turno queda visible en el listado de turnos del usuario que lo reservó, identificado con el nombre de la persona atendida.

Depende de: US-13 (turno reservado) FC

Trazabilidad: RF-TUR-11, RF-PAG-01, RN-12

Pagos y coberturas

US-32 — Gestión de la cobertura médica

Must | 2 pts | 6,6 h | Sprint 3

Como paciente, quiero consultar y corregir la obra social o prepaga registrada —la mía y la de las personas para las que saco turnos—, para que se aplique el descuento correcto al abonar la consulta.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El alta de la cobertura ocurre en el registro del usuario (US-01) o al cargar a una persona para reservar en su nombre (US-64); esta historia cubre su consulta y corrección posterior.
- La entidad se selecciona de un listado administrado por el administrador.
- Cada obra social del listado tiene un descuento porcentual predefinido, configurado por el administrador, que se aplica sobre el precio de consulta sin cobertura (US-33); los pacientes particulares no reciben descuento.
- Se registran entidad, plan y número de afiliado.
- Un paciente puede no tener cobertura, en cuyo caso se lo considera particular.
- El dato es declarativo: el sistema no valida contra el padrón de la entidad.
- Los datos de plan y número de afiliado son declarativos y no intervienen en el cálculo del precio: el médico define un único precio sin cobertura (US-33) y la obra social del paciente determina el descuento que se le aplica.
- El personal administrativo también puede cargar o corregir la cobertura de cualquier paciente.
- Cada cambio de cobertura queda registrado con autor y fecha; los pagos ya registrados conservan la cobertura aplicada en su momento.

Depende de: US-64 (persona atendida distinta del titular) FC

Trazabilidad: RF-PAG-01, RF-USR-01, RF-TUR-11, RN-06, RN-12

US-33 — Definición del costo de la consulta por el médico

Must | 2 pts | 6,6 h | Sprint 3

Como médico, quiero definir el precio de mi consulta sin cobertura, para que el sistema calcule el importe que debe abonar cada paciente aplicando el descuento de su obra social sobre ese precio.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Cada médico define el valor de su propia consulta desde su perfil; el administrador no lo fija por especialidad.
- El valor rige desde una fecha determinada y el sistema conserva el historial de vigencias.
- El médico define un único precio de consulta, correspondiente a la atención sin cobertura (particular); no define un precio distinto por cada obra social.
- El importe que abona un paciente con obra social surge de aplicar sobre ese precio el descuento predefinido de esa obra social (US-32).
- Al modificarse el costo, los pagos ya registrados conservan el valor vigente al momento del cobro.
- Un médico solo puede ver y modificar el costo de sus propias consultas.

Depende de: US-03 (usuarios internos con rol asignado) FC

Trazabilidad: RF-PAG-02, RNF-03, RN-14

US-34 — Cálculo del importe según cobertura

Must | 3 pts | 9,9 h | Sprint 3

Como sistema, quiero calcular el importe a abonar aplicando el descuento de la obra social del paciente sobre el precio de consulta del médico, para cobrar el valor correcto sin cálculos manuales en el mostrador.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Un paciente sin cobertura abona el precio particular definido por el médico que lo atendió.
- Un paciente con obra social abona el precio del médico con el descuento predefinido de esa obra social (US-32) ya aplicado.
- El cálculo usa el precio vigente a la fecha de la consulta.
- Si el turno fue reservado a nombre de otra persona, se aplica la cobertura de la persona atendida.
- La pantalla muestra el desglose: precio de la consulta sin cobertura, descuento aplicado según la obra social e importe final.
- Si el médico no tiene configurado un precio de consulta, el sistema lo advierte y no permite cerrar el cobro.

Depende de: US-18 (turno en estado cumplido) FC, US-32 (cobertura del paciente) FC, US-33 (costo de la consulta) FC

Trazabilidad: RF-PAG-03, RN-06, RN-12, RN-14

US-35 — Registro del pago en efectivo o por transferencia

Must | 2 pts | 6,6 h | Sprint 3

Como personal administrativo, quiero registrar el pago de una consulta indicando si fue en efectivo o por transferencia, para dejar asentado el cobro y poder emitir el comprobante.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El pago se asocia a un turno en estado cumplido.
- Los medios de pago admitidos son únicamente efectivo y transferencia, ambos presenciales; no son configurables.
- El pago en efectivo solo puede registrarlo el personal administrativo.
- El pago por transferencia se registra contra el comprobante que presenta el paciente en el mostrador, asentando la referencia de la operación.
- Un turno no puede tener dos pagos activos simultáneos.
- El sistema registra fecha, hora, importe, medio de pago y usuario que lo registró.
- El sistema solo registra el pago; no procesa la transacción en línea.

Depende de: US-34 (importe calculado) FC

Trazabilidad: RF-PAG-04, RNF-04, RN-13

US-36 — Comprobante de pago en PDF

Must | 2 pts | 6,6 h | Sprint 3

Como paciente, quiero obtener y descargar en PDF un comprobante por cada pago que realizo, para tener constancia de lo abonado y poder presentárselo a mi cobertura.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El comprobante se genera automáticamente al registrarse el pago, en formato PDF.
- Incluye numeración correlativa, datos de la sala, datos del paciente atendido, prestación, profesional, importe y medio de pago.
- Es un comprobante interno, sin homologación fiscal: no se emite factura electrónica ni ningún otro documento aparte.
- El comprobante queda disponible en la cuenta del paciente y puede descargarse las veces que haga falta.
- La descarga solo está disponible para el paciente titular, para quien reservó el turno y para el personal administrativo.
- La numeración no presenta huecos ni duplicados.

Depende de: US-35 (pago registrado) FC

Trazabilidad: RF-PAG-05, RF-PAG-06, RNF-03

Historial clínico

US-39 — Ficha de diagnóstico del paciente

Must | 3 pts | 9,9 h | Sprint 3

Como médico, quiero registrar el diagnóstico y el tratamiento de cada consulta sobre la ficha que mantengo de ese paciente, para dejar asentada la evolución clínica en un solo lugar.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Existe una única ficha de diagnóstico por cada par paciente–médico. La primera consulta del paciente con ese profesional la crea; todas las siguientes agregan entradas a la misma ficha.
- Un mismo paciente tiene tantas fichas como médicos distintos lo hayan atendido, y cada médico es el autor de una sola de ellas.
- La carga se realiza sobre un turno en estado cumplido.
- Se registran diagnóstico, tratamiento indicado y observaciones.
- Cada entrada queda firmada con el profesional, la fecha y la hora, tomados del usuario autenticado, y registra la fecha y hora de su última edición.
- Solo un usuario con rol Médico puede realizar la carga.
- Desde la carga de una nueva entrada hay un acceso directo a la ficha consolidada del paciente con las de los demás médicos (US-40).
- Todas las entradas de la ficha son visibles para cualquier médico de la sala; solo su autor puede editarlas, y únicamente durante el día de la consulta.
- Pasado el día de la consulta, la entrada queda en solo lectura y toda corrección se registra como una entrada nueva sobre la misma ficha.

Depende de: US-18 (turno en estado cumplido) FC

Trazabilidad: RF-HIS-01, RNF-03, RN-07

US-40 — Consulta de la ficha del paciente

Must | 2 pts | 6,6 h | Sprint 3

Como médico, quiero ver el historial completo del paciente con las fichas de todos los profesionales de la sala, para atender con el contexto clínico completo.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- La vista consolida las fichas de todos los médicos que atendieron al paciente, identificando autor y especialidad de cada una.
- Puede buscarse y filtrarse por paciente (documento o apellido), además de por profesional, especialidad o rango de fechas.
- Dentro de cada ficha, las entradas se muestran en orden cronológico inverso.
- El médico edita únicamente su propia ficha, y solo durante el día de la consulta, desde US-39; esta vista consolidada es siempre de solo lectura, incluida la ficha propia del día.
- Se registra la fecha y hora de la última edición de cada entrada.
- El acceso queda registrado en el log de auditoría.

Depende de: US-39 (ficha de diagnóstico) CC+2D

Trazabilidad: RF-HIS-02, RNF-03, RN-07

US-41 — Historial clínico del paciente

Must | 2 pts | 6,6 h | Sprint 3

Como paciente, quiero consultar mi historial médico desde la plataforma, para tener acceso a mis diagnósticos y tratamientos sin pedir una copia.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El paciente accede en modo de solo lectura, sin posibilidad de modificar ni eliminar.
- Ve las entradas de todas sus fichas, con el mismo texto cargado por cada profesional y sin notas internas.
- Solo accede a su propia información; cualquier intento de acceder a la de otro paciente es rechazado y registrado.
- El historial puede descargarse en PDF.

Depende de: US-39 (ficha de diagnóstico) CC+2D

Trazabilidad: RF-HIS-03, RNF-03

US-44 — Auditoría de accesos al historial

Should | 1 pt | 3,3 h | Sprint 3

Como responsable del sistema, quiero registrar cada acceso al historial clínico de un paciente, para poder investigar accesos indebidos a información sensible.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Se registra usuario, paciente consultado, fecha, hora y tipo de acceso.
- El registro incluye tanto los accesos exitosos como los intentos rechazados por RNF-03.
- El log es de solo lectura y accesible únicamente para el administrador.
- El administrador puede filtrar el log por usuario, paciente y rango de fechas.

Depende de: US-40 (consulta de la ficha) FC, US-41 (historial del paciente) FC

Trazabilidad: RF-HIS-06, RNF-03, RNF-04

US-62 — Adjuntar estudios a la ficha

Could | 3 pts | 9,9 h | Sprint 3

Como médico, quiero adjuntar estudios y archivos a la ficha del paciente, para centralizar la información clínica en un solo lugar.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Se admiten formatos de imagen y PDF con un tamaño máximo configurable.
- Cada adjunto queda vinculado a una entrada de la ficha de diagnóstico del profesional que lo carga.
- El paciente puede descargar sus propios adjuntos.
- El acceso a los adjuntos se registra en el log de auditoría.

Depende de: US-39 (ficha de diagnóstico)

Trazabilidad: RF-HIS-07, RNF-03

Agenda médica, mostrador y avisos

US-30 — Bloqueo de turnos disponibles de una franja publicada

Should | 2 pts | 6,6 h | Sprint 3

Como médico, quiero bloquear los turnos aún libres de una franja ya publicada por ausencia o licencia, para evitar que los pacientes reserven horarios que no voy a poder atender.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El médico selecciona un rango de fechas u horas y confirma el bloqueo indicando el motivo.
- El personal administrativo también puede bloquear franjas a pedido de los médicos.
- Los turnos disponibles del rango dejan de ofrecerse.
- Los turnos ya reservados quedan fuera del bloqueo y no se modifican (RF-AGE-09): el sistema los lista aparte y dispara el aviso a los pacientes afectados para que el mostrador acuerde la cancelación con cada uno.
- El sistema advierte la cantidad de turnos reservados involucrados antes de confirmar.
- El bloqueo puede revertirse mientras no hayan pasado las fechas involucradas.

Depende de: US-10 (agenda publicada al paciente), US-13 (turno reservado)

Trazabilidad: RF-AGE-06, RF-AGE-09, RF-NOT-02, RN-10

US-22 — Aviso por modificación de agenda

Must | 1 pt | 3,3 h | Sprint 3

Como paciente, quiero ser avisado si el profesional bloquea la franja en la que tenía mi turno, para poder reprogramar a tiempo.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Al bloquearse una franja, el sistema identifica los turnos reservados dentro de ella y notifica por email a los pacientes afectados.
- Los turnos reservados no se modifican automáticamente (RF-AGE-09): su cancelación la resuelve el personal administrativo en acuerdo con el paciente.
- El email indica el turno afectado y cómo reprogramarlo.
- El personal administrativo obtiene un listado de los pacientes a contactar.

Depende de: US-21 (servicio de envío de email), US-30 (bloqueo de franja publicada)

Trazabilidad: RF-NOT-02, RF-AGE-06, RF-AGE-09, RN-10

US-17 — Gestión de turnos desde mostrador

Should | 3 pts | 9,9 h | Sprint 3

Como personal administrativo, quiero reservar, reprogramar y cancelar turnos en nombre de un paciente, para atender a quienes se comunican por teléfono o vienen presencialmente.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El administrativo busca al paciente por documento, apellido o email.
- Puede registrar un paciente nuevo desde el mismo flujo si no está en el sistema, incluyendo su obra social.
- Puede gestionar turnos de ambos tipos: consulta médica y vacunación.
- La reprogramación se resuelve como cancelación del turno original más reserva de uno nuevo, en una sola operación atendida por el sistema. En ningún caso se edita un turno reservado.
- Para los turnos ya ocurridos, puede marcar la asistencia del paciente (cumplido o ausente), igual que el médico (US-18); marcarlo cumplido habilita el cálculo del importe y el registro del pago (US-34, US-35).
- El paciente recibe el email correspondiente a la acción realizada.
- Toda operación queda registrada indicando qué usuario la realizó.

Depende de: US-03 (usuarios internos con rol asignado), US-13 (turno reservado), US-16 (cancelación de turno), US-18 (registro del estado del turno)

Trazabilidad: RF-TUR-06, RF-TUR-07, RF-AGE-09, RN-10

Reportes

US-45 — Reporte de turnos por especialidad

Must | 2 pts | 6,6 h | Sprint 3

Como administrador, quiero obtener la cantidad de turnos por especialidad y período, para evaluar la demanda de cada profesional y ajustar la disponibilidad.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Muestra turnos totales, cumplidos, ausentes y cancelados por especialidad.
- Puede desglosarse por profesional.
- Admite un rango de fechas definido por el usuario.
- Incluye una representación gráfica de la distribución.

Depende de: US-18 (turno en estado cumplido) FC

Trazabilidad: RF-REP-01, RN-08

US-47 — Reporte de pagos realizados

Must | 1 pt | 3,3 h | Sprint 3

Como administrador, quiero obtener el detalle de los pagos por período, medio de pago y cobertura, para controlar la recaudación de la sala.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El reporte totaliza importes por período, medio de pago (efectivo y transferencia) y entidad de cobertura.
- Distingue consultas particulares de consultas con cobertura.
- Los pagos anulados se muestran identificados y no suman al total.
- Admite desglose por especialidad y por profesional.

Depende de: US-35 (pago registrado) FC

Trazabilidad: RF-REP-03, RN-13

US-48 — Reporte de asistencia de pacientes

Must | 1 pt | 3,3 h | Sprint 3

Como administrador, quiero conocer el nivel de ausentismo a los turnos, para tomar medidas sobre los turnos que se pierden.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El reporte calcula el porcentaje de ausentismo sobre los turnos reservados del período.
- Puede desglosarse por profesional, especialidad, tipo de turno y día de la semana.
- Identifica a los pacientes con mayor cantidad de ausencias.
- Excluye del cálculo los turnos cancelados por la sala.

Depende de: US-18 (turno en estado cumplido)

Trazabilidad: RF-REP-04

Filtros comunes y exportación de reportes

Requerimiento especial | 0 pts | incluido en los reportes

Los filtros comunes (rango de fechas, profesional, especialidad y tipo de turno) y la exportación a PDF o CSV no se estiman como historias de usuario: se implementan como parte de los reportes de US-45, US-47 y US-48, con trazabilidad directa a RF-REP-05 y RF-REP-06.

Aplicación móvil — reemplazada por RNF-08

RNF-08 — Compatibilidad y diseño adaptable

Must | 0 pts | transversal | Sprints 1 a 3

Como paciente, quiero usar el sistema desde el navegador de mi teléfono con la misma funcionalidad que desde una computadora, para no depender de instalar una aplicación.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Toda pantalla del sistema es usable en anchos de 360 px o más, sin desplazamiento horizontal.
- Las credenciales y la funcionalidad son las mismas: no hay registro ni sesión separados, que es lo que pedía US-51.
- Los flujos de reserva, cancelación y consulta del historial funcionan desde el teléfono, cubriendo US-52 y US-53.
- Los recordatorios y confirmaciones llegan por email, que es accesible desde el teléfono; no hay notificaciones push, a diferencia de US-54.
- El comprobante de pago en PDF se descarga desde el teléfono, cubriendo US-55.
- Los puntos de corte se definen en el refinement del Sprint 1, antes de construir la primera pantalla.

US-51 — Acceso desde la aplicación móvil

Must | 2 pts | 6,6 h | Fuera de alcance

Como paciente, quiero ingresar a la aplicación móvil con las mismas credenciales del sistema web, para no tener que gestionar dos cuentas distintas.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Las credenciales son las mismas que en la web; no existe un registro separado.
- La sesión en el móvil es independiente de la sesión web.
- La aplicación solo está disponible para el rol Usuario.
- El diseño mantiene la identidad visual del sistema web.

Depende de: US-02 (sesión y ruteo por rol)

Trazabilidad: RF-MOV-01, RNF-03, RNF-06

US-52 — Gestión de turnos desde el móvil

Must | 3 pts | 9,9 h | Fuera de alcance

Como paciente, quiero buscar, reservar y cancelar turnos desde mi teléfono, para resolver el turno en el momento en que me acuerdo, sin abrir la computadora.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El flujo replica las reglas de la versión web, incluida la elección del tipo de turno y la reserva a nombre de otra persona.
- La pantalla está adaptada a dispositivos móviles.
- Los turnos reservados desde el móvil son los mismos que se ven en la web.
- Las validaciones de concurrencia, duplicados y no modificación de turnos reservados se aplican por igual. (reserva a nombre de un tercero)

Depende de: US-13 (turno reservado), US-16 (cancelación de turno), US-51 (sesión en la aplicación móvil), US-64

Trazabilidad: RF-MOV-02, RF-TUR-01, RF-TUR-11, RF-AGE-09

US-53 — Historial clínico desde el móvil

Must | 2 pts | 6,6 h | Fuera de alcance

Como paciente, quiero consultar mi historial médico desde la aplicación, para tenerlo a mano cuando lo necesito.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Se muestra la misma información que en la web, en modo de solo lectura.
- El acceso exige sesión activa y se registra en el log de auditoría.
- La información no se almacena en el dispositivo tras cerrar sesión.

Depende de: US-41 (historial del paciente), US-51 (sesión en la aplicación móvil)

Trazabilidad: RF-MOV-03, RNF-02, RNF-03

US-54 — Recordatorios en el móvil

Must | 1 pt | 3,3 h | Fuera de alcance

Como paciente, quiero recibir los recordatorios de turno en la aplicación, para enterarme sin depender de revisar el correo.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Los recordatorios se muestran en una sección de avisos dentro de la aplicación.
- Incluyen los turnos de ambos tipos.
- El envío por email se mantiene en paralelo.
- La notificación emergente queda fuera del alcance de esta versión, según lo acordado con el cliente.

Depende de: US-15 (recordatorio por email), US-51 (sesión en la aplicación móvil)

Trazabilidad: RF-MOV-04

US-55 — Pagos y comprobantes desde el móvil

Should | 2 pts | 6,6 h | Fuera de alcance

Como paciente, quiero consultar mis pagos y descargar los comprobantes desde la aplicación, para no tener que pasar por el mostrador para pedirlos.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El listado de pagos replica el de la versión web.
- El comprobante en PDF puede descargarse o compartirse desde el dispositivo.
- El registro del pago se sigue realizando presencialmente en el mostrador, en efectivo o por transferencia; la aplicación solo consulta.

Depende de: US-36 (comprobante en PDF), US-38 (historial de pagos), US-51 (sesión en la aplicación móvil)

Trazabilidad: RF-MOV-05, RN-13

Reserva de turnos y agenda

US-19 — Prevención de turnos duplicados del mismo tipo

Should | 1 pt | 3,3 h | Fuera de alcance

Como sistema, quiero impedir que un paciente reserve más de un turno del mismo tipo con el mismo profesional en la misma fecha, para evitar reservas por error y el bloqueo innecesario de horarios.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Al intentar la segunda reserva del mismo tipo, el sistema informa el turno ya existente y ofrece cancelarlo para reservar otro.
- La restricción no aplica entre un turno médico y uno de vacunación: ambos pueden coexistir e incluso superponerse en el mismo horario para la misma persona.
- La restricción no aplica a turnos con profesionales de distinta especialidad.
- Un turno cancelado previamente no cuenta para esta validación.

Depende de: US-13 (turno reservado)

Trazabilidad: RF-TUR-08, RN-08

US-59 — Lista de espera de turnos

Could | 3 pts | 9,9 h | Fuera de alcance

Como paciente, quiero anotarme en una lista de espera cuando no hay turnos disponibles, para aprovechar los horarios que se liberan por cancelaciones.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El paciente se anota indicando tipo de turno, especialidad, profesional y rango de fechas de interés.
- Al liberarse un turno que cumple el criterio, se notifica a los anotados en orden de inscripción.
- La notificación otorga un plazo acotado de prioridad antes de liberar el turno al público general.
- El paciente puede darse de baja de la lista en cualquier momento.

Depende de: US-16 (cancelación de turno), US-21 (servicio de envío de email)

Trazabilidad: RF-TUR-10

US-60 — Calendario de feriados

Could | 2 pts | 6,6 h | Fuera de alcance

Como administrador, quiero cargar los feriados y días no laborables de la sala, para que no se generen turnos en fechas en que no se atiende.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El administrador carga fechas puntuales o rangos con una descripción.
- La generación automática de turnos excluye esas fechas, tanto para las agendas médicas como para el vacunatorio.
- Si se agrega un feriado sobre fechas con turnos ya reservados, el sistema advierte antes de aplicarlo y no los modifica.
- El calendario puede consultarse por año.

Depende de: US-08 (turnos de 30 minutos generados), US-63 (agenda del vacunatorio)

Trazabilidad: RF-AGE-08, RF-AGE-09

Usuarios y notificaciones

US-31 — Recuperación de contraseña

Should | 1 pt | 3,3 h | Fuera de alcance

Como usuario registrado, quiero recuperar el acceso si olvido mi contraseña, para no depender del personal de la sala para volver a entrar.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El usuario solicita la recuperación indicando su email.
- El sistema envía un enlace de un solo uso con vencimiento acotado.
- La respuesta en pantalla es la misma exista o no la cuenta, para no revelar usuarios registrados.
- Al definirse la nueva contraseña, el enlace queda invalidado.

Depende de: US-02 (sesión y ruteo por rol), US-21 (servicio de envío de email)

Trazabilidad: RF-USR-06, RNF-01

US-58 — Registro de notificaciones enviadas

Should | 1 pt | 3,3 h | Fuera de alcance

Como administrador, quiero consultar el registro de las notificaciones que envió el sistema, para diagnosticar reclamos por avisos que el paciente dice no haber recibido.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El log guarda destinatario, tipo de notificación, fecha, hora y estado de envío.
- Los envíos fallidos quedan identificados con el motivo del fallo.
- El log puede filtrarse por paciente, tipo y rango de fechas.
- Solo es accesible para el rol Administrador.

Depende de: US-21 (servicio de envío de email)

Trazabilidad: RF-NOT-04, RNF-03

Pagos y coberturas

US-38 — Historial de pagos del paciente

Should | 1 pt | 3,3 h | Fuera de alcance

Como paciente, quiero consultar el listado de mis pagos y comprobantes, para revisar lo abonado sin tener que pedirlo en el mostrador.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- El listado muestra fecha, prestación, profesional, importe y medio de pago.
- Puede filtrarse por rango de fechas.
- Desde cada fila se accede al comprobante en PDF.
- El paciente solo ve sus propios pagos y los de las personas a cuyo nombre reservó turnos.

Depende de: US-36 (comprobante en PDF)

Trazabilidad: RF-PAG-07, RNF-03

US-61 — Anulación de pagos

Could | 2 pts | 6,6 h | Fuera de alcance

Como personal administrativo, quiero anular un pago registrado por error, para corregir el cobro sin alterar la trazabilidad contable.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- La anulación exige indicar un motivo.
- El pago original no se elimina; queda marcado como anulado y su comprobante en PDF, invalidado.
- Los reportes descuentan el importe anulado del total del período.
- Se registra quién realizó la anulación y cuándo.

Depende de: US-35 (pago registrado), US-36 (comprobante en PDF)

Trazabilidad: RF-PAG-08, RNF-04

Historial clínico

US-42 — Trazabilidad de las entradas clínicas

Should | 2 pts | 6,6 h | Fuera de alcance

Como responsable del sistema, quiero que ninguna entrada del historial pueda eliminarse y que toda corrección quede trazada, para preservar la integridad de la información clínica.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- No existe ninguna función de eliminación de entradas del historial en ninguna interfaz.
- Una corrección se registra como entrada nueva vinculada a la original, sobre la misma ficha.
- La ficha muestra las correcciones junto a la entrada corregida, sin ocultar la versión previa.
- Cada entrada conserva autor, fecha y hora de creación.

Depende de: US-39 (ficha de diagnóstico)

Trazabilidad: RF-HIS-04, RNF-02, RNF-04

US-43 — Antecedentes, alergias y medicación habitual

Should | 1 pt | 3,3 h | Fuera de alcance

Como médico, quiero consultar y actualizar los antecedentes, alergias y medicación habitual del paciente, para evitar indicaciones que puedan ser riesgosas.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Estos datos son del paciente, no de una ficha en particular: son comunes a todas sus fichas de diagnóstico.
- La vista clínica tiene una sección destacada con alergias, visible para todos los profesionales.
- Se registran antecedentes personales y medicación habitual.
- El paciente puede consultar esta sección pero no modificarla.
- Cada modificación queda registrada con autor y fecha.

Depende de: US-39 (ficha de diagnóstico)

Trazabilidad: RF-HIS-05, RN-07
